

Panduan Penatalaksanaan Perilaku, Perawatan, dan Pencegahan Gigi pada Pasien Anak Epilepsi



Pilih waktu pemeriksaan yang aman.

adwalkan perawatan saat risiko kejang paling rendah.



Kurangi stres.

Jelaskan prosedur terlebih dahulu untuk menenangkan pasien.



Pastikan pasien telah minum obat antiepilepsi.

Periksa apakah pasien sudah minum obat antiepilepsi sesuai resep sebelum perawatan untuk mengurangi risiko kejang.



Hindari cahaya terang.

Bila perlu, biarkan pasien memakai kacamata gelap.



Penanganan Kejang Saat Perawatan:

- Segera keluarkan semua instrumen dari mulut.
- Kosongkan area di sekitar kursi perawatan.
- Tetap bersama pasien dan posisikan miring ke salah satu sisi.
- Awasi jalan napas untuk mencegah aspirasi.
- Catat waktu kejang dimulai; bila berlangsung lebih dari 3 menit, segera hubungi EMS karena berisiko status epilepticus (kondisi yang berpotensi mengancam nyawa).

Panduan Penatalaksanaan Perilaku, Perawatan, dan Pencegahan Gigi pada Pasien Anak Epilepsi

Perawatan Gigi dan Pencegahan:

- Lakukan anamnesis lengkap, termasuk pemicu kejang, frekuensi, dan tingkat kontrol kejang.
- Pantau adanya hiperplasia gingiva akibat obat antiepilepsi. Kebersihan mulut yang baik adalah pencegahan utama. Pada kasus berat, mungkin diperlukan reduksi bedah.
- Sikat gigi elektrik bisa terlalu merangsang bagi sebagian pasien; gunakan hanya jika pasien dapat mentoleransinya.
- Jika merencanakan restorasi prostetik, pastikan aman terhadap laju, tingkat, dan frekuensi kejang, serta cukup kuat untuk menghindari kerusakan atau terlepas saat serangan sehingga tidak menimbulkan risiko tersedak.
- Pertimbangkan penggunaan mouth guard untuk pasien dengan epilepsi yang tidak terkontrol.
- Pasien dengan epilepsi berat yang tidak terkontrol mungkin memerlukan anestesi umum untuk perawatan restoratif atau bedah.

Pertimbangan Tambahan:

- Beberapa pasien dengan kebutuhan khusus mungkin menggunakan feeding tube (gastrik/nasogastrik). Pasien dengan feeding tube biasanya memiliki risiko karies rendah tetapi cepat mengalami akumulasi kalkulus, GERD, hipersensitivitas oral, dan risiko aspirasi tinggi.
- Tidak diperlukan antibiotik profilaksis untuk pasien dengan feeding tube. Posisikan pasien setegak mungkin, gunakan air semiminal mungkin, dan hisap dengan suction berdaya tinggi untuk mengurangi risiko aspirasi.